

Faringoamigdalite · viral × estreptococo

Maioria é viral. Trate estreptococo do grupo A para abreviar sintomas e prevenir febre reumática — use critérios + teste quando disponível.

Clínica de SGA

Dica - Clínica de SGA

Febre, dor de garganta, exsudato, adenomegalia cervical dolorosa, ausência de tosse/coriza.

Petéquias de palato e rash escarlatiniforme reforçam.

Evite ATB 'por precaução' em coriza/tosse — padrão viral.

Faringite pediátrica

Clinica -> teste -> ATB se SGA

Escore

febre, exsudato, adenopatia

Teste/cultura

se disponível

Penicilina

se SGA

Conduta

- 1ª linha: penicilina V ou amoxicilina; benzatina se adesão duvidosa
- Alergia não anafilática: cefalosporina; anafilaxia: macrolídeo/clinda conforme guia
- Retorno escolar após 24 h de ATB se afebril
- Abscesso peritonsilar: voz abafada, trismo — drenagem + ATB

Viral × bacteriana

Pista | Viral | SGA

Coriza/tosse | Comum | Rara

Exsudato | Variável | Frequente

Idade <3 anos | Mais viral | SGA menos típico

ATB | Não | Sim se confirmado/alta probabilidade

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Não use amoxicilina empírico em mononucleose suspeita (rash). Em faringite + dificuldade respiratória, pense epiglottite/abscesso — via aérea primeiro.

Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

Centor/McIsaac estratifica probabilidade de SGA e reduz ATB desnecessário em faringite viral.

Somar pontos: febre, ausência de tosse, adenopatia, exsudato e ajuste por idade.

Mclsaac / Centor modificado

Escore para SGA

Febre > 38 °C	1
Ausencia de tosse	1
Adenopatia cervical anterior	1
Exsudato / inflamacao tonsilar	1
Idade 3-14 anos	1
Idade 15-44 anos	0
Idade >= 45 anos	-1

Baixo: sintomatico; intermediario: teste; alto: tratar/testar

Coriza/tosse apontam viral. SGA confirmado: penicilina/amoxicilina.

Fluxo faringite

Escore -> teste -> ATB



Interpretação prática do escore

Pontuação | Conduta típica

- 0-1 | Baixa probabilidade — sintomáticos; sem ATB de rotina
- 2-3 | Teste rápido/cultura se disponível
- 4 | Alta probabilidade — tratar ou testar conforme recurso

Tratamento SGA

- 1ª linha: penicilina V ou amoxicilina; benzatina se adesão duvidosa
- Objetivo: sintomas + prevenção de febre reumática
- Retorno escolar após 24 h de ATB se afebril
- Abscesso peritonsilar: voz abafada, trismo — drenagem

Armadilha

Atenção - Armadilha

Não use amoxicilina empírico em mononucleose suspeita (rash). Em <3 anos, SGA clássico é menos típico — maioria viral.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1